

DOCUMENTO PARA JUNTA MÉDICA

Síntesis ejecutiva — apto para discusión interdisciplinaria

11 / 06 / 2026

PACIENTE

Andrés Felipe Romero Castaño

DOCUMENTO

CC 79555123

EDAD

33 años, 0 meses

ESCOLARIDAD / OCUPACIÓN

Profesional (Derecho) · Abogado (licencia médica)

PROTOCOLO

WAIS-III + BDI-II + Evaluación Post-ACV

CIE-10

F06.9

MOTIVO DE INTERCONSULTA

Pregunta clínica que motiva la presentación

Control post-ACV isquémico de ACM izquierda (hace 8 meses). Hemiparesia derecha resuelta, persiste leve déficit atencional y anomia. Evaluar capacidad para reincorporación laboral.

RESUMEN EJECUTIVO

Pirámide invertida: conclusión, hallazgos, implicación

Conclusión

Andrés obtuvo un CIT de 88 (promedio bajo), con un perfil asimétrico: IMT=90 es el índice más bajo. El CIT resume pero no captura la variabilidad.

Hallazgos clave

- Velocidad de Proceso severamente descendido ($Z=-2.3\sigma$)

Implicación

Se recomienda intervención prioritaria en el dominio con mayor descenso, con seguimiento cercano de la evolución.

RESULTADOS CLAVE

Síntesis cuantitativa

CI COMPRENSIÓN V	CI DEL INDICE OR	CI INDICE MEMORI	CI INDICE VELOCI	CI ESCALA TOTAL	Inventario de Be
136	129	90	134	88	14
Superior	Superior	Promedio	Superior	Promedio	Leve

Andrés obtuvo un Cociente Intelectual Total (CIT) de 88, ubicándose en la categoría promedio bajo (percentil aproximado 21). Se observa una variabilidad relevante entre sus índices compuestos: el más bajo corresponde a IMT (90) y el más alto a ICV (136), lo que sugiere un perfil asimétrico que conviene analizar por separado más que resumir en una única puntuación global.

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: velocidad de proceso (severamente disminuido, $Z=-2.3$).

Debilidades

- CLAVE DE NÚMEROS — bajo ($Z=-2.33$)
- FIG. INCOMPLETAS — límite ($Z=-1.67$)
- ROMPECABEZAS — promedio ($Z=-1.00$)